

03. ORIGINE DE L'ŒIL

DURÉE : 07:12

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur l'origine de l'œil, qui se développe à partir du diencéphalique, dès le huitième jour du développement embryonnaire. L'accent est mis sur l'importance de la cavité amniotique et du liquide céphalorachidien (LCR), ainsi que sur la manière dont ces éléments influencent la formation de l'œil et son équilibre dynamique avec l'environnement. La relation entre la cavité amniotique, le système ventriculaire, et l'œil est mise en avant, tout en soulignant les implications cliniques et génétiques qui peuvent affecter la santé de l'individu et se manifester à travers l'œil. Cette compréhension peut aider les thérapeutes à évaluer et à rétablir l'équilibre chez leurs patients, rendant l'enseignement essentiel pour ceux qui pratiquent l'ostéopathie et l'embryologie biodynamique.

ORIGINE DE L'ŒIL

L'œil présente une **ressemblance** fascinante avec sa formation au huitième jour du développement embryonnaire, moment où apparaît une petite cavité appelée **cavité amniotique**. Cette cavité est fondamentale pour le développement de l'œil, qui provient du **cerveau**, plus précisément du **diencéphale**, une expansion du troisième ventricule.



Schéma relatif à l'origine de l'oeil à partir du diencéphale, en lien avec le troisième ventricule

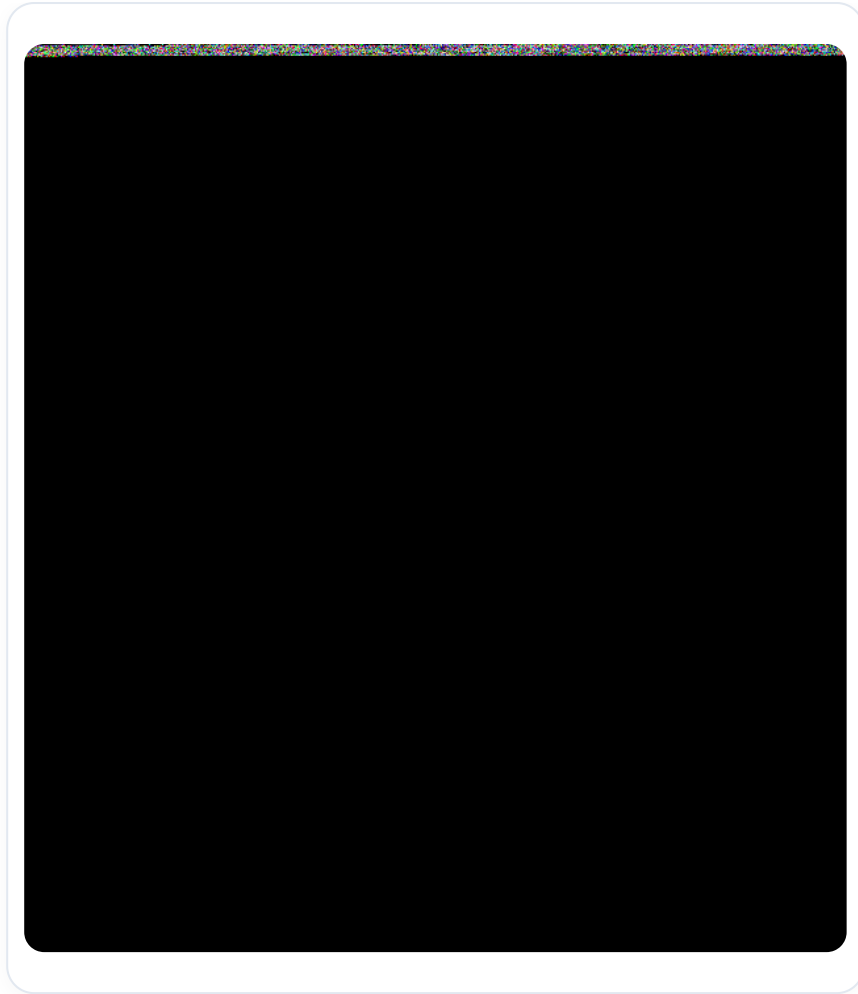
Au cours de ce développement, le système neuronal reçoit du **liquide amniotique primitif**, qui va former le **liquide céphalorachidien (LCR)**. Ce premier LCR, dérivé du liquide amniotique, va être enfermé dans le tube neural.



Schéma de l'apparition de la cavité amniotique, qui est mentionnée juste après cette phrase dans le résumé

Par la suite, ce tube s'ouvre vers l'avant, formant des **vésicules primitives**.

Le vestige de cette cavité amniotique se retrouve dans ce qu'on appelle la **poche des os** ou **zone B**, où se trouve du liquide céphalo-rachidien.



Vestige de la cavité amniotique (zone B)

Il est intéressant de noter que le liquide à l'intérieur et à l'extérieur de l'embryon est le même. L'œil, en tant que membrane, cherche constamment à équilibrer cette zone B.

La zone A est représentée par l'axe central du corps physique, tandis que la cavité amniotique commence à se former au huitième jour, marquant l'entrée dans la **muqueuse**. À ce stade, une perte de liquide centrale crée une petite cavité, et l'**ectoderme**, appelé à ce stade **épiblaste**, commence à se mettre en place.



Processus d'implantation : formation de la cavité

Cela constitue déjà la structure subtile qui formera l'œil et le cerveau.

La cavité amniotique, qui entoure l'embryon pendant neuf mois, devient ensuite un espace vaporeux.



Cavité amniotique

Cet espace doit être en équilibre avec le liquide intérieur. Des déséquilibres peuvent survenir, notamment en cas d'accidents, affectant la position de l'œil. L'œil représente ainsi un équilibre entre la profondeur du liquide du système nerveux (LCR) et l'espace environnant.

Observer la position des yeux peut révéler des informations sur l'équilibre d'une personne. Chaque individu a un œil légèrement différent, souvent en rapport avec l'architecture de son cerveau. La recherche d'une **horizontalité** par rapport à une **verticalité** est essentielle, tout comme l'équilibre entre le système digestif et le système péritonéal.

Il est crucial d'observer les yeux après un traitement. Si la position des yeux n'est pas stable, cela indique que l'équilibre n'est pas encore rétabli. La cavité amniotique, bien qu'elle ne soit plus sous forme liquide, reste présente sous d'autres états, comme gazeux.

Cette relation entre la cavité amniotique, l'œil et le système ventriculaire est fondamentale. L'œil, en tant qu'expansion du troisième ventricule, commence à se développer avant la fermeture du **neuroport antérieur**. De plus, il existe des implications génétiques intéressantes, avec des co-localisations d'informations sur des zones d'impact, telles que le système hépatopancréatique, cardiaque et thyroïdien.

Des pathologies comme le **diabète**, les problèmes cardiaques et thyroïdiens peuvent se manifester à travers l'œil, révélant ainsi l'importance de la **crête neurale** dans l'organisation de l'axe médian et la latéralité.